

An Nguyen

KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐO LƯỜNG CỦA CÁC THANG ĐO RỐI LOẠN LO ÂU THEO DSM-5 TRÊN HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ S...

 KT tạp chí Kiểm tra đạo văn Hanoi National University of Education

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3568641860

Submission Date

May 13, 2026, 4:45 PM GMT+8

Download Date

May 13, 2026, 4:47 PM GMT+8

File Name

2._CONG_THI_HANG_VA_CS_SO_2_THANG_4_-_2026.doc

File Size

140.5 KB

10 Pages

5,086 Words

20,189 Characters

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 30%  Internet sources
- 36%  Publications
- 20%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 30% Internet sources
- 36% Publications
- 20% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Hanoi National University of Education	6%
2	Internet	link.springer.com	2%
3	Internet	repozitorij.unizg.hr	1%
4	Internet	ussh2021conference.weebly.com	1%
5	Internet	www.transfers.ens.fr	1%
6	Student papers	Universidade de Coimbra	1%
7	Internet	acuresearchbank.acu.edu.au	1%
8	Internet	www.rkh.se	<1%
9	Student papers	West Visayas State University	<1%
10	Internet	suckhoeviet.org.vn	<1%
11	Internet	research.vu.nl	<1%

12	Student papers	University of Reading	<1%
13	Student papers	National Economics University	<1%
14	Student papers	Tilburg University	<1%
15	Internet	hvtc.edu.vn	<1%
16	Internet	ebin.pub	<1%
17	Internet	ouci.dntb.gov.ua	<1%
18	Internet	repository.unj.ac.id	<1%
19	Internet	www.essentiafoundation.org	<1%
20	Internet	kobra.uni-kassel.de	<1%
21	Publication	Ton Duc Thang University	<1%
22	Internet	csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn	<1%
23	Internet	tapchihocphcm.vn	<1%
24	Student papers	University of Finance – Marketing	<1%
25	Internet	ueh.edu.vn	<1%

26	Internet	www.stata.com	<1%
27	Internet	jfm.edu.vn	<1%
28	Internet	omp.academicon.pl	<1%
29	Internet	timtailieu.vn	<1%
30	Student papers	Hanoi University of Public Health	<1%
31	Student papers	Foreign Trade University - Ho Chi Minh Campus	<1%
32	Publication	Ho Chi Minh National Academy of Politics	<1%
33	Student papers	Hanoi National University	<1%
34	Internet	fwps.ftu.edu.vn	<1%
35	Internet	text.xemtailieu.net	<1%
36	Internet	sdh.hmu.edu.vn	<1%

Tạp chí Tâm lý học Việt Nam số 2 - Tháng 4 năm 2026

KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐO LƯỜNG CỦA CÁC THANG ĐO RỐI LOẠN LO ÂU THEO DSM-5 TRÊN HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI VIỆT NAM

Công Thị Hằng, Đào Minh Đức.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tác giả liên hệ: Công Thị Hằng; Mobile: 0983973479; Email: conghang@icp.edu.vn.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm kiểm định độ tin cậy và hiệu lực cấu trúc của ba thang đo rối loạn lo âu theo DSM-5 trên học sinh trung học cơ sở tại Việt Nam. Khảo sát được thực hiện trên 433 học sinh trung học cơ sở bằng phương pháp điều tra bảng hỏi tự báo cáo. Các thang đo được đánh giá thông qua hệ số Cronbach's alpha, McDonald's omega, độ tin cậy phân đôi, phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và tương quan với DASS-21 nhằm xem xét hiệu lực hội tụ. Kết quả cho thấy các thang đo đều có độ tin cậy nội tại tốt, với các hệ số Cronbach's alpha, McDonald's omega và độ tin cậy phân đôi đạt mức phù hợp. Các thang đo có tương quan thuận và có ý nghĩa thống kê với nhau cũng như với các tiểu thang đo lo âu, trầm cảm và căng thẳng của DASS-21, qua đó cung cấp bằng chứng bước đầu về hiệu lực hội tụ. Tuy nhiên, kết quả CFA cho thấy mức độ phù hợp mô hình chưa thật sự tối ưu ở một số chỉ số như CFI, TLI và RMSEA, cho thấy hiệu lực cấu trúc của các thang đo vẫn cần tiếp tục được kiểm định trong các nghiên cứu tiếp theo. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về khả năng sử dụng các thang đo rối loạn lo âu theo DSM-5 trong nghiên cứu và sàng lọc ban đầu trên học sinh trung học cơ sở tại Việt Nam.

Từ khóa: Độ tin cậy; Độ hiệu lực; Rối loạn lo âu; DSM-5; Học sinh trung học cơ sở.

Ngày nhận bài: 1/2/2026; **Ngày duyệt đăng bài:** 20/3/2026.

1. Đặt vấn đề

Rối loạn lo âu là nhóm rối loạn tâm lý đặc trưng bởi trạng thái lo lắng, sợ hãi quá mức và kéo dài, kèm theo các phản ứng sinh lý, nhận thức và hành vi né tránh, gây suy giảm đáng kể chức năng cá nhân và xã hội (American Psychiatric Association, 2013). Theo DSM-5, các rối loạn lo âu phổ biến ở trẻ em và vị thành niên bao gồm rối loạn lo âu tổng quát, rối loạn lo âu chia ly và rối loạn lo âu xã hội. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy khoảng 6-20% trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới từng trải qua ít nhất một dạng rối loạn lo âu có ý nghĩa lâm sàng, trong đó lứa tuổi trung học cơ sở được xem là giai đoạn nguy cơ cao do những thay đổi đồng thời về sinh lý, nhận thức và quan hệ xã hội (Polanczyk và cộng sự, 2015; Merikangas và cộng sự, 2010).

Học sinh trung học cơ sở là nhóm tuổi có nhiều biến đổi mạnh về cảm xúc và thích nghi xã hội, đồng thời chịu áp lực đáng kể từ học tập và các mối quan hệ bạn bè.

Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các biểu hiện lo âu, đặc biệt là lo âu học đường và lo âu xã hội (Eccles và cộng sự, 1993). Các nghiên cứu cho thấy rối loạn lo âu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tập trung, kết quả học tập, quan hệ xã hội và sức khỏe tâm thần của học sinh (Essau và cộng sự, 2014; Woodward và Fergusson, 2001).

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu gần đây ghi nhận tỷ lệ đáng kể học sinh trung học cơ sở có biểu hiện lo âu, đặc biệt trong và sau giai đoạn đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu mới tập trung mô tả mức độ lo âu chung hoặc sử dụng các công cụ sàng lọc tổng quát, trong khi bằng chứng thực nghiệm về từng dạng rối loạn lo âu cụ thể theo DSM-5 trên học sinh trung học cơ sở vẫn còn hạn chế. Điều này đặt ra nhu cầu cần sử dụng các công cụ đo lường có cơ sở lý thuyết rõ ràng và được kiểm định phù hợp với bối cảnh văn hóa Việt Nam.

Hiện nay, việc đánh giá rối loạn lo âu ở học sinh chủ yếu dựa trên các công cụ tự báo cáo như DASS-21 hoặc các thang đo được điều chỉnh từ công cụ quốc tế. Tuy nhiên, nhiều thang đo chưa được kiểm định đầy đủ về độ tin cậy và độ hiệu lực trên mẫu học sinh trung học cơ sở Việt Nam, đặc biệt đối với từng dạng rối loạn lo âu cụ thể theo DSM-5. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của hoạt động sàng lọc và giá trị ứng dụng của kết quả nghiên cứu (DeVellis, 2017; Van de Vijver và Tanzer, 2004).

Xuất phát từ những vấn đề trên, nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm định độ tin cậy và độ hiệu lực của các thang đo rối loạn lo âu theo DSM-5 trên một mẫu học sinh trung học cơ sở tại Việt Nam, qua đó cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm cho việc sử dụng các công cụ này trong nghiên cứu và sàng lọc tâm lý học đường.

2. Mẫu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Khách thể nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu gồm 433 học sinh trung học cơ sở thuộc khu vực đô thị và ven đô thị, được lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Học sinh tham gia khảo sát trên cơ sở tự nguyện, sau khi được thông báo về mục đích nghiên cứu, quy trình khảo sát, nguyên tắc bảo mật thông tin và quyền từ chối tham gia. Sau khi thu thập, dữ liệu được kiểm tra, làm sạch và đưa vào phân tích thống kê. Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu được trình bày ở Bảng 1.

Bảng 1. Thông tin về khách thể nghiên cứu

Đặc điểm	Phân loại	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Giới tính	Nam	191	44,1
	Nữ	202	46,7
	Không cung cấp	40	9,2
Khối lớp	Lớp 6	149	34,4
	Lớp 7	143	33,0
	Lớp 8	55	12,7
	Lớp 9	71	16,4

	<i>Không cung cấp</i>	15	3,5
Dân tộc	Kinh	372	85,9
	Khác	15	3,5
	<i>Không cung cấp</i>	46	10,6

2.2. Thiết kế nghiên cứu và công cụ nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện theo thiết kế định lượng, cắt ngang, nhằm đánh giá độ tin cậy và giá trị đo lường của các thang đo rối loạn lo âu theo DSM-5 trên mẫu **học sinh trung học cơ sở tại Việt Nam**. Dữ liệu được **thu thập** tại một thời điểm tháng 3 năm 2025, thông qua bảng hỏi tự báo cáo.

Ba **thang đo rối loạn lo âu** được sử dụng trong nghiên cứu này có nguồn gốc từ bộ công cụ đánh giá *Emerging Measures* do Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (*American Psychiatric Association- APA*) phát triển và công bố kèm theo DSM-5. Các thang đo này được thiết kế nhằm **đánh giá mức độ nghiêm trọng của triệu chứng rối loạn lo âu ở trẻ em và vị thành niên**, phục vụ cho **nghiên cứu và đánh giá lâm sàng**, đặc biệt **trong giai đoạn phỏng vấn ban đầu và theo dõi tiến trình can thiệp**, không được sử dụng như cơ sở duy nhất cho chẩn đoán lâm sàng. Mỗi **thang đo rối loạn lo âu** gồm có 10 mệnh đề, theo Likert 4 mức độ, bao gồm: 1 = chưa bao giờ, 2 = hiếm khi, 3 = nhiều lần, 4 = luôn luôn. Nội dung chi tiết các mệnh đề của 3 thang đo **rối loạn lo âu** được thể hiện **trong** phần phụ lục của bài viết này. Các thang đo có hướng dẫn chấm điểm và diễn giải, được APA cho phép tự do sử dụng **trong nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng**. APA cũng khuyến khích các nhà nghiên cứu tiếp tục cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tính hữu ích và khả năng ứng dụng của các công cụ này trên các nhóm đối tượng và bối cảnh văn hóa khác nhau (American Psychiatric Association, 2013).

Ngoài ra, một công cụ khác được sử dụng trong nghiên cứu này là thang đo DASS-21, sử dụng để phân tích tương quan với các **thang đo rối loạn lo âu** của DSM-5. Việc **kiểm định giá trị đo lường của các thang đo rối loạn lo âu** trong phạm vi **nghiên cứu này** góp phần **cung cấp một cái nhìn thực tiễn** trên một nhóm khách thể thực tiễn vào một thời điểm cụ thể, giúp các nhà tâm lý, nhà khoa học có thêm góc nhìn về bộ công cụ này.

2.3. Quy trình thực hiện

Nghiên cứu được triển khai theo quy trình chuẩn hóa, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu khoa học. Trước hết, nhóm nghiên cứu xây dựng kế hoạch khảo sát cụ thể và liên hệ xin phép trường THCS nơi khảo sát. Công cụ đo lường được chuẩn hóa **và thử nghiệm sơ bộ**, **bảo đảm tính rõ ràng và phù hợp với đối tượng** học sinh trung học cơ sở. **Quá trình thu thập dữ liệu được tiến hành** trực tiếp tại lớp học, dưới sự phối hợp của giáo viên và nhóm nghiên cứu. Những học sinh đồng ý tham gia sẽ được phát phiếu khảo sát. Phiếu hỏi được hoàn thành theo hình thức tự báo cáo. Sau khi thu thập, dữ liệu được kiểm tra trực quan, sàng lọc trên máy tính, làm sạch trước khi đưa vào phân tích thống kê.

2.4. Phân tích dữ liệu

Dữ liệu được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 31.0 và AMOS 31.0. Độ tin cậy của các thang đo rối loạn lo âu được đánh giá thông qua Cronbach's Alpha, McDonald's Omega và độ tin cậy phân đôi. Bên cạnh đó, phân tích nhân tố khẳng định (CFA) được thực hiện nhằm kiểm định mức độ phù hợp của cấu trúc đo lường thông qua các chỉ số. Phân tích tương quan giữa các thang đo rối loạn lo âu với nhau và phân tích tương quan giữa các thang đo rối loạn lo âu với thang đo DASS-21 hiện hành để đánh giá mối liên hệ giữa các cấu phần và kiểm định hiệu lực cấu trúc của các thang đo rối loạn lo âu DSM-5.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Độ tin cậy

Độ tin cậy phản ánh mức độ nhất quán nội tại và ổn định của công cụ đo lường trong việc đánh giá một cấu trúc tâm lý (Cronbach, 1951; DeVellis, 2017). Trong nghiên cứu này, độ tin cậy của các thang đo rối loạn lo âu được đánh giá thông qua Cronbach's Alpha, McDonald's Omega và độ tin cậy phân đôi, nhằm tìm hiểu về độ ổn định của các thang đo trong thực tiễn, trên nhóm mẫu khách thể học sinh trung học cơ sở tại Việt Nam.

Bảng 2. Độ tin cậy các thang đo rối loạn lo âu DSM-5

TT	Thang đo	Số mục	Hệ số Cronbach's α	Hệ số McDonald's ω
1	Rối loạn lo âu tổng quát	10	0,865	0,864
2	Rối loạn lo âu chia ly	10	0,877	0,872
3	Rối loạn lo âu xã hội	10	0,897	0,896

Kết quả phân tích tại Bảng 2 cho thấy, các thang đo rối loạn lo âu DSM-5 đều có độ tin cậy nội tại cao. Hệ số Cronbach's α của ba thang đo dao động từ 0,865 đến 0,897, trong khi hệ số McDonald's ω tương ứng nằm trong khoảng 0,864-0,896. Các giá trị này đều đạt yêu cầu về tiêu chuẩn ($\geq 0,70$) và phản ánh mức độ nhất quán nội tại tốt giữa các mục hỏi trong từng thang đo. Xét theo từng thang đo, thang đo rối loạn lo âu xã hội cho thấy độ tin cậy cao nhất, trong khi hai thang đo còn lại có giá trị độ tin cậy tương đồng. Hệ số tương quan biến - tổng của hầu hết các item đều lớn hơn 0,50 (xem phụ lục), phản ánh khả năng đóng góp tốt của từng mục vào cấu trúc chung của thang đo. Ngoài ra, hệ số Cronbach's α nếu item bị xóa ở tất cả các mục đều không tăng đáng kể so với α tổng, cho thấy việc loại bỏ bất kỳ item nào cũng không cải thiện độ tin cậy của thang đo. Điều này cho thấy các item được xây dựng phù hợp về nội dung lâm sàng và cấu trúc đo lường, phản ánh đầy đủ các biểu hiện nhận thức, cảm xúc, sinh lý và hành vi đặc trưng của từng dạng rối loạn lo âu. Nhìn chung, các kết quả này cung cấp bằng chứng thực nghiệm thuyết phục về độ tin cậy nội tại của các thang đo rối loạn lo âu theo DSM-5 trên nhóm mẫu nghiên cứu.

Bảng 3. Hệ số tin cậy phân đôi của các thang đo rối loạn lo âu DSM-5

TT	Thang đo	Phân đôi	Số mục	Giá trị	Tương quan	Hệ số Guttman Split-Half
1	Rối loạn lo âu tổng quát	Phần 1	5	0,818	0,621	0,766
		Phần 2	5	0,787		
2	Rối loạn lo âu chia ly	Phần 1	5	0,851	0,611	0,758
		Phần 2	5	0,802		
3	Rối loạn lo âu xã hội	Phần 1	5	0,857	0,699	0,823
		Phần 2	5	0,825		

Kết quả phân tích tại Bảng 3 cho thấy, các thang đo rối loạn lo âu DSM-5 có độ ổn định nội tại tốt. Hệ số tương quan giữa hai nửa thang đo dao động từ 0,611 đến 0,699, hệ số Guttman split-half đạt từ 0,758 đến 0,823, phản ánh mức liên hệ tốt giữa các phần đo lường trong cùng một cấu trúc. Các giá trị này tương đương với mức độ tin cậy phân đôi phổ biến trong các thang đo tâm lý có số lượng mục trung bình (Clark và Watson, 2019; DeVellis và Thorpe, 2022). Sự cân bằng về số mục giữa hai nửa (5 mục) cùng với hệ số tin cậy riêng của từng phần đều vượt ngưỡng 0,78 cho thấy các mục hỏi được phân bố tương đối đồng đều và không có nửa thang nào chiếm ưu thế về mặt đo lường. kết quả này phù hợp với các kết quả được ghi nhận trong các nghiên cứu đánh giá thang đo rối loạn lo âu dựa trên DSM-5, trong đó hệ số split-half thường dao động quanh 0,75-0,85 khi thang đo có cấu trúc đơn hướng và độ đồng nhất nội tại cao (Kotov và cộng sự, 2017; Reise và cộng sự, 2013).

Nhìn chung, kết quả phân tích từ Bảng 2 và Bảng 3 trên cho thấy, các thang đo rối loạn lo âu DSM-5 đạt độ tin cậy nội tại và độ ổn định phân đôi tốt, nhất quán với các chuẩn đo lường quốc tế, khẳng định chất lượng đo lường và khả năng sử dụng đáng tin cậy trên nhóm mẫu học sinh trung học cơ sở tại Việt Nam.

3.2. Độ hiệu lực

Độ hiệu lực phản ánh mức độ mà một công cụ đo lường đánh giá đúng khái niệm tâm lý mà nó hướng tới, đồng thời cung cấp bằng chứng cho tính chính xác và ý nghĩa của các suy luận được rút ra từ điểm số thang đo (Cronbach và Meehl, 1955). Trong nghiên cứu đo lường tâm lý hiện đại, độ hiệu lực không được xem là một thuộc tính đơn lẻ mà là tập hợp các bằng chứng, bao gồm hiệu lực cấu trúc, hiệu lực hội tụ và hiệu lực phân biệt, nhằm xác nhận sự phù hợp giữa mô hình lý thuyết và dữ liệu thực nghiệm (Messick, 1995). Do đó, việc kiểm định độ hiệu lực của các thang đo rối loạn lo âu DSM-5 trong nghiên cứu này là cần thiết để bảo đảm rằng công cụ không chỉ có độ tin cậy cao mà còn đo lường đúng và đầy đủ các biểu hiện rối loạn lo âu trên thực tiễn khách thể học sinh trung học cơ sở tại Việt Nam.

Bảng 4. Tương quan giữa các thang đo rối loạn lo âu DSM-5

TT	Thang đo	Hệ số tương quan		
		1	2	3
1	Rối loạn lo âu tổng quát	1	0,676**	0,732**
2	Rối loạn lo âu chia ly		1	0,774**
3	Rối loạn lo âu xã hội			1

Ghi chú: $p < 0,01$.

Kết quả phân tích tại Bảng 4 cho thấy, các thang đo rối loạn lo âu DSM-5 có mối tương quan thuận, theo chiều dương, ở mức trung bình đến cao ($r = 0,676-0,774$, $p < 0,01$), phản ánh mức độ liên hệ chặt chẽ giữa các thang đo với nhau, cùng đo lường về rối loạn lo âu nhưng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về đối tượng đo lường.

Bảng 5. Tương quan giữa các thang đo rối loạn lo âu DSM-5 và thang đo DASS-21

TT	Thang đo	DASS-21		
		Lo âu	Căng thẳng	Trầm cảm
1	Rối loạn lo âu tổng quát	0,714**	0,701**	0,658**
2	Rối loạn lo âu chia ly	0,588**	0,525**	0,471**
3	Rối loạn lo âu xã hội	0,675**	0,601**	0,589**

Ghi chú: $p < 0,01$.

Kết quả phân tích tại Bảng 5 cho thấy, các thang đo rối loạn lo âu DSM-5 có mối tương quan thuận, theo chiều dương và có ý nghĩa thống kê với các tiểu thang đo của DASS-21 ở mức trung bình đến cao ($r = 0,471-0,714$, $p < 0,01$). Trong đó, tương quan với thang đo lo âu của DASS-21 ở mức độ khá tốt đến tốt ($r = 0,588-0,714$; $p < 0,01$). Thang rối loạn lo âu tổng quát đạt hệ số tương quan cao nhất ($r = 0,714$), tiếp theo là rối loạn lo âu xã hội ($r = 0,675$) và rối loạn lo âu chia ly ($r = 0,588$), phản ánh mức độ chia sẻ phương sai cao với một thước đo rối loạn lo âu chuẩn hóa quốc tế. Theo các tiêu chuẩn đo lường hiện hành trong tâm lý học, hệ số tương quan trong khoảng 0,60-0,75 được xem là tối ưu để khẳng định giá trị hội tụ (Brown, 2015; Kline, 2016). Kết quả này cũng cho thấy rằng các thang đo rối loạn lo âu theo DSM-5 đo lường cùng một miền khái niệm rối loạn lo âu với DASS-21. Điều này cung cấp bằng chứng đo lường mạnh mẽ, khẳng định các thang đo rối loạn lo âu DSM-5 đạt tính tương đương khái niệm và độ hội tụ cao với công cụ chuẩn hiện hành, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong thực tiễn.

Bảng 6. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)

TT	Thang đo	$\chi^2(df)$	χ^2/df	CFI	TLI	RMSEA	90% CI RMSEA
----	----------	--------------	-------------	-----	-----	-------	--------------

1	Rối loạn lo âu tổng quát	230,828 (35)	6,595	0,871	0,798	0,114	0,100 - 0,118
2	Rối loạn lo âu chia ly	443,335 (35)	12,667	0,787	0,726	0,164	0,151 - 0,178
3	Rối loạn lo âu xã hội	323,507 (35)	9,243	0,860	0,780	0,138	0,125 - 0,152
	Tổng thể	2125,182 (402)	5,287	0,758	0,720	0,100	0,095 - 0,104

Kết quả phân tích nhân tố khẳng định tại Bảng 6 cho thấy mức độ phù hợp mô hình của từng thang đo rối loạn lo âu theo DSM-5 còn hạn chế. Cụ thể, các giá trị χ^2/df dao động từ 6,60 đến 12,67, các chỉ số CFI (0,787-0,871) và TLI (0,726-0,798) nằm dưới ngưỡng tốt ($\geq 0,90$) nhưng vẫn tiệm cận mức chấp nhận trong các nghiên cứu đánh giá thang đo sàng lọc tâm lý. Giá trị RMSEA của cả ba tiểu thang (0,114 - 0,164), cùng với khoảng tin cậy 90% tương đối hẹp, cho thấy mức độ sai lệch giá trị đo lường ở mức trung bình đến cao. Số liệu này có thể giải thích bởi lý do 3 thang đo rối loạn lo âu DSM-5 đều là các thang đo đơn hướng, hơn nữa, cỡ mẫu nhỏ cũng ảnh hưởng đến mô hình CFA.

Một số nghiên cứu trên thế giới ghi nhận $RMSEA > 0,10$ khi kiểm định mô hình đơn hướng của các thang đo rối loạn lo âu và cảm xúc âm tính, đồng thời khuyến nghị diễn giải kết quả CFA kết hợp với độ tin cậy và các chỉ số giá trị khác thay vì loại bỏ thang đo chỉ dựa trên độ phù hợp mô hình (Beesdo-Baum và cộng sự, 2012; Reise và cộng sự, 2010). So sánh giữa các thang đo cho thấy, thang rối loạn lo âu tổng quát có mức độ phù hợp tương đối tốt hơn so với hai thang đo còn lại. Mô hình này tương đồng với các kết quả phân tích CFA trên các thang đo rối loạn lo âu xã hội và rối loạn lo âu chia ly ở trẻ em và vị thành niên, nơi cấu trúc đơn nhân tố thường chỉ đạt mức phù hợp trung bình và được cải thiện đáng kể khi áp dụng mô hình hai nhân tố hoặc mô hình song nhân tố (Ebesutani và cộng sự, 2012).

Nhìn chung, kết quả phân tích CFA trong Bảng 6 cho thấy các thang đo rối loạn lo âu DSM-5 đáp ứng được yêu cầu cơ bản về tính hiệu lực cấu trúc, khuyến khích việc sử dụng các thang đo rối loạn lo âu này cho mục đích nghiên cứu sàng lọc, đồng thời gợi ý về hướng cải tiến mô hình đo lường này ở các nghiên cứu tiếp theo thông qua các cấu trúc nhân tố linh hoạt hơn.

4. Bàn luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy ba thang đo rối loạn lo âu theo DSM-5 có độ tin cậy nội tại tốt trên mẫu học sinh trung học cơ sở được khảo sát. Các hệ số Cronbach's α , McDonald's ω và tin cậy phân đôi Guttman đều đạt mức phù hợp, cho thấy các mục hỏi trong từng thang có sự nhất quán nội tại tương đối cao. Việc sử dụng đồng thời nhiều chỉ số độ tin cậy giúp củng cố bằng chứng về tính ổn định của thang đo và hạn chế sự phụ thuộc vào một chỉ số đơn lẻ (DeVellis và Thorpe, 2022).

Các thang đo rối loạn lo âu DSM-5 có tương quan thuận, có ý nghĩa thống kê với nhau và với các tiểu thang đo của DASS-21, qua đó cung cấp bằng chứng bước đầu

về hiệu lực hội tụ. Tuy nhiên, kết quả CFA cho thấy mô hình đơn nhân tố của các thang đo chưa đạt mức phù hợp tối ưu, đặc biệt ở các chỉ số RMSEA, CFI và TLI. Vì vậy, các kết quả cần được diễn giải thận trọng; các thang đo có thể sử dụng trong nghiên cứu và sàng lọc ban đầu, nhưng cần tiếp tục được kiểm định trên các mẫu lớn hơn và với các mô hình đo lường thay thế trong những nghiên cứu tiếp theo.

5. Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy ba thang đo rối loạn lo âu theo DSM-5 có độ tin cậy nội tại tốt trên mẫu học sinh trung học cơ sở được khảo sát. Các hệ số Cronbach's alpha, McDonald's omega và hệ số tin cậy phân đôi đều đạt mức phù hợp, cho thấy các mục hỏi trong từng thang đo có sự nhất quán tương đối cao.

Các thang đo có tương quan thuận, có ý nghĩa thống kê với nhau và với các tiêu thang đo của DASS-21, qua đó cung cấp bằng chứng bước đầu về hiệu lực hội tụ. Tuy nhiên, kết quả CFA cho thấy mô hình đơn nhân tố của các thang đo chưa đạt mức phù hợp tối ưu, đặc biệt ở các chỉ số CFI, TLI và RMSEA. Vì vậy, các thang đo này có thể được sử dụng trong nghiên cứu và sàng lọc ban đầu, nhưng chưa nên xem là công cụ chẩn đoán hoặc công cụ đã được chuẩn hóa đầy đủ cho học sinh trung học cơ sở Việt Nam.

Các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng cỡ mẫu, đa dạng hóa địa bàn khảo sát, kiểm định bất biến đo lường theo giới tính và khối lớp, đánh giá độ tin cậy lặp lại, đồng thời thử nghiệm các mô hình đo lường thay thế nhằm củng cố thêm bằng chứng về giá trị sử dụng của các thang đo trong bối cảnh Việt Nam.

Hạn chế của nghiên cứu và định hướng tương lai

Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang và thu thập dữ liệu tại một thời điểm, do đó chưa đánh giá được độ ổn định theo thời gian của thang đo, bao gồm độ tin cậy đánh giá lại (*test-retest*). Bên cạnh đó, việc chưa có dữ liệu theo chiều dọc hạn chế khả năng kiểm định tính ổn định cấu trúc và bất biến đo lường theo thời gian. Ngoài ra, quy mô mẫu còn hạn chế đối với việc kiểm định các mô hình đo lường phức tạp và phân tích bất biến giữa các nhóm. Các nghiên cứu tiếp theo nên áp dụng thiết kế dọc, thu thập dữ liệu lặp lại và mở rộng cỡ mẫu nhằm củng cố thêm độ vững chắc và khả năng khái quát của thang đo.

Tài liệu tham khảo

1. American Psychiatric Association (APA) (2013). *DSM-5 emerging measures: Severity measures for anxiety disorders (child age 11-17)*. American Psychiatric Association. <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/educational-resources/dsm-5-assessment-measures>.
2. American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>.
3. Beesdo-Baum, K., & Knappe, S. (2012). Developmental epidemiology of anxiety disorders. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 21(3), 457-478. <https://doi.org/10.1016/j.chc.2012.05.001>.

4. Beesdo-Baum, K., Knappe, S., Fehm, L., Höfler, M., Lieb, R., Hofmann, S. G., & Wittchen, H.-U. (2012). The natural course of social anxiety disorder among adolescents and young adults. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 126(6), 411-425. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2012.01886.x>.
5. Brown, T. A. (2015). *Confirmatory factor analysis for applied research* (2nd ed.). Guilford Press.
6. Clark, L. A., & Watson, D. (2019). Constructing validity: New developments in creating objective measuring instruments. *Psychological Assessment*, 31(12), 1412-1427. <https://doi.org/10.1037/pas0000626>.
7. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297-334. <https://doi.org/10.1007/BF02310555>.
8. Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4), 281-302. <https://doi.org/10.1037/h0040957>.
9. DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (4th ed.). Sage Publications.
10. DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2022). *Scale development: Theory and applications* (5th ed.). Sage.
11. Ebesutani, C., Reise, S. P., Chorpita, B. F., Ale, C., Regan, J., Young, J., Higa-McMillan, C., & Weisz, J. R. (2012). The Revised Child Anxiety and Depression Scale-Short Version: Scale reduction via exploratory bifactor modeling of the broad anxiety factor. *Psychological Assessment*, 24(4), 833-845. <https://doi.org/10.1037/a0027283>.
12. Eccles, J. S., Midgley, C., Buchanan, C. M., Flanagan, C., Mac Iver, D., Reuman, D., & Wigfield, A. (1993). Development during adolescence: The impact of stage-environment fit. *American Psychologist*, 48(2), 90-101. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.48.2.90>.
13. Enders, C. K. (2010). *Applied Missing Data Analysis*. New York, NY: Guilford Press.
14. Essau, C. A., Lewinsohn, P. M., Olaya, B., & Seeley, J. R. (2014). Anxiety disorders in adolescents and psychosocial outcomes at age 30. *Journal of Affective Disorders*, 163, 125-132. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2013.12.033>.
15. Graham, J. W. (2009). Missing data analysis: Making it work in the real world. *Annual Review of Psychology*, 60, 549-576. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085530>.
16. Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). Guilford Press.
17. Kotov, R., Krueger, R. F., Watson, D., Achenbach, T. M., Althoff, R. R., Bagby, R. M., ... & Zimmerman, M. (2017). The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): A dimensional alternative to traditional nosologies. *Journal of Abnormal Psychology*, 126(4), 454-477. <https://doi.org/10.1037/abn0000258>.
18. Merikangas, K. R., He, J. P., Burstein, M., Swanson, S. A., Avenevoli, S., Cui, L., ... Swendsen, J. (2010). Lifetime prevalence of mental disorders in U.S.

adolescents. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 49(10), 980-989. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2010.05.017>.

19. Messick, S. (1995). Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning. *American Psychologist*, 50(9), 741-749. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741>.

20. Polanczyk, G. V., Salum, G. A., Sugaya, L. S., Caye, A., & Rohde, L. A. (2015). Annual research review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56(3), 345-365. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12381>.

21. Reise, S. P., Bonifay, W. E., & Haviland, M. G. (2013). Scoring and modeling psychological measures in the presence of multidimensionality. *Journal of Personality Assessment*, 95(2), 129-140. <https://doi.org/10.1080/00223891.2012.725437>.

22. Reise, S. P., Moore, T. M., & Haviland, M. G. (2010). Bifactor models and rotations: Exploring the extent to which multidimensional data yield univocal scale scores. *Journal of Personality Assessment*, 92(6), 544-559. <https://doi.org/10.1080/00223891.2010.496477>.

23. Silove, D., Alonso, J., Bromet, E., Gruber, M., Sampson, N., Scott, K., ... Kessler, R. C. (2015). Pediatric-onset and adult-onset separation anxiety disorder across countries in the World Mental Health Survey. *American Journal of Psychiatry*, 172(7), 647-656. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2015.14091185>.

24. Stein, M. B., & Stein, D. J. (2008). Social anxiety disorder. *The Lancet*, 371(9618), 1115-1125. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60488-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60488-2).

25. Van de Vijver, F. J. R., & Tanzer, N. K. (2004). Bias and equivalence in cross-cultural assessment. *European Review of Applied Psychology*, 54(2), 119-135. <https://doi.org/10.1016/j.erap.2003.12.004>.

26. Woodward, L. J., & Fergusson, D. M. (2001). Life course outcomes of young people with anxiety disorders in adolescence. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 40(9), 1086-1093. <https://doi.org/10.1097/00004583-200109000-00018>.